

2026년 6차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

직전 차수 통과 약제 deep dive · 6/4 6차 안건 후보 · 정책 환경 변화

회의	약제급여평가위원회 2026년 제6차
일자	2026-06-04 (목)
직전 차수	2026-05-07 제5차 약평위 (HIRA 공식 brdBltno=11793)
위원회	10기 약평위 (2025-09 출범, 위원 74명 중 30명 유임·44명 신규) — 위원장 정현철 (심평원 상근위원, 연세암센터 출신 종양내과 전문의·한국임상암학회 이사장)
정부 인사	2026-05-18 강준혁 신임 보험약제과장 부임 — 본 회의가 첫 정기 의결
정책 환경	2026-06-01 약가 유연계약제 첫 시행 — 본 회의가 시행 후 첫 약평위

들어가며

본 보고서는 약제급여평가위원회를 중심으로, 직전 4·5차 약평위 통과 약제 각각의 통과 쟁점·조건·히스토리를 매체 보도 기반으로 deep dive 하고 6/4 6차 회의의 안건 후보·정책 환경을 정리한다.

본 시스템의 일별 모니터링 결과 한 가지 중요한 진전이 자동 감지됐다 — **2026년 제1차 암질심 통과 약제 4종 중 자카비 (노바티스, 진성적혈구증가증)는 5/1 직접 급여 시행, 포말리스트(BMS, 다발골수종)는 6/1 직접 급여 시행이 확인됐다.** 즉 1차 암질심 통과 4종 중 2종이 약평위를 거치지 않고 별도 트랙으로 급여 진입한 것이며, 본 보고서의 안건 후보 분석에서 두 약물은 제외됐다.

이전 보고서가 약평위와 암질심을 함께 다뤘던 것에 비해, 본 보고서는 한국 reimbursement pipeline의 실질적 결정권을 가진 약평위에 초점을 맞춰 시장 환경과 후속 의사결정 시사점을 정리한다.

1. 5/7 5차 약평위 통과 약제 — Deep Dive

심평원 공식 보도자료(brdBltno=11793)는 본 차수에서 결정신청 5종, 신약 승인 2종, 위험분담 확대 1종, 재심의 1종을 명시했다. 항암제·중증질환 신약 4종을 깊이 본다.

1-1. 예스카타주 (axicabtagene ciloleucel) — 길리어드코리아 · CAR-T · 림프종

통과 쟁점: 글로벌 두 번째 CD19 CAR-T로, 한국 시장에는 노바티스 킴리아가 이미 reference price를 설정해 둔 상태(한자부담 최대 598만원 수준, 산정특례)였다. 핵심 쟁점은 (1) 2차(1차 화학면역요법 후 12개월 내 재발·불응 DLBCL) 대 3차(2차 이상 전신치료 후 재발·불응)의 적응증 분리, (2) CAR-T 1회 투여 글로벌 가격이 4~5억원대인 점에서 발생하는 재정 부담, (3) 신규 CAR-T 약가의 킴리아 reference 차별화 폭이었다.

통과 조건: "평가금액 이하 수용 시" 조건부 통과. 적응증은 **3차로 제한** — 2차 적응증은 본 차수 약평위 통과 실패. 후속 단계는 NHIS 약가협상(60일 + 1회 연장) → 건정심 → 고시.

통과 히스토리: 2021-03 식약처 허가 → 2024 1차 적응증(DLBCL 2차) 추가 허가 → 2026-01 1차 암질심 통과(3차만) → **2026-05-07 5차 약평위 통과(3차만)**. 한국 reimbursement journey 약 5년. 글로벌 reference: FDA 2017, EMA 2018, NICE 2019.

시장 함의: 후속 NHIS 협상이 향후 림카토(큐로셀 국산 CAR-T) 약가 협상의 reference로 작용할 가능성. 글로벌 CAR-T 가격 ceiling 형성의 분기점.

1-2. 레테브모캡슐 (셀퍼카티닙) — 한국릴리 · RET 표적 · 폐암·갑상선암

통과 쟁점: 국내 최초 RET 표적 항암제로 단독품목 성격이 강해 ICER 임계값 적용 여유. 다만 (1) RET fusion+ NSCLC와 RET-mutant MTC, RET fusion+ 갑상선암 3개 적응증 동시 평가의 복잡성, (2) 비교약제 부재로 인한 LIBRETTO-001 single-arm trial 평가의 불확실성이 핵심이었다.

통과 조건: 3개 적응증 모두 급여 적정성 인정(조건 단서 없이). 적응증: ① 국소진행성·전이성 RET fusion+ NSCLC, ② 진행성·전이성 RET-mutant MTC, ③ 소라페닙·렌바티닙 치료 경험 RET fusion+ 갑상선암. 단독품목 RSA 적용 예상.

통과 히스토리: 2022 식약처 허가(국내 첫 RET 타깃 신약) → 2022~2025 암질심 다회 도전 끝 통과 → 2026-05-07 5차 약평위 통과. 글로벌: FDA 2020-05 가속승인 → 2022 정식승인.

시장 함의: precision oncology의 small subpopulation drug이 한국에서 단독품목 우대 경로로 안착한 사례.

1-3. 티센트릭주 (아테졸리주맙) — 한국로슈 · NSCLC adjuvant 확대 · RSA ★ MSD 직접 영향

통과 쟁점: 신약 등재가 아닌 기존 RSA 약제의 사용범위 확대 트랙. 핵심 이슈는 (1) **수술 후 보조요법(adjunct) 영역의 면역항암제 확대** — IMpower010 DFS 데이터는 PD-L1 ≥50% subgroup에서 가장 강했으나 OS 데이터 미성숙, (2) 기존 진행성·전이성 NSCLC 1차 RSA와 별개의 early-stage 환자 풀 추가로 BIA 큰 폭 증가, (3) 키트루다 adjuvant(KEYNOTE-091)와의 class effect였다.

통과 조건: RSA 확대 적정성 인정. 확대 적응증은 "PD-L1 발현 비율 종양세포 50% 이상, 병기 II~IIIA 초기 NSCLC, 절제 및 백금기반 화학요법 후 수술 후 보조요법" — PD-L1 50%+ subpopulation 한정으로 BIA 통제. 기존 진행성 NSCLC 1차 (2021 급여) 적응증은 유지된 상태에서 adjuvant 영역만 추가.

통과 히스토리: 2017 국내 허가 → 2021 NSCLC 1차 단독요법 급여 → 2022 보조요법 식약처 적응증 추가 → 2026-05-07 5차 약평위 RSA 확대 통과.

시장 함의 (MSD 자산 직접 영향): 면역항암제 adjuvant 시장의 한국 진입 본격화이며, **본 PD-L1 50%+ subpopulation 한정 RSA logic은 향후 한국MSD 키트루다 KEYNOTE-091 adjuvant 등재 협상의 직접 reference**가 된다. PD-L1 cutoff 적용·BIA 통제 방식·기존 RSA 위에 추가 layer 형식 — 모든 logic이 키트루다 후속 협상에 그대로 적용될 가능성.

1-4. 리브리반트주 (아미반타맙) — 한국얀센 · EGFR 변이 NSCLC · 재심의

통과 쟁점 (가장 첨예): (1) 이상반응 부담 — 약평위가 "최근 이상반응이 중요 판단요소"라 명시(피부독성·infusion reaction), (2) 재정 부담 — 연간 약값 약 1.5억원, 록라자 병용 시 추가 가중, (3) 병용요법 약가 산정 logic 불명확 — 록라자(국산)와의 cost-sharing 협상 구조 미정립, (4) 환자단체 청원과 국회 압력 — 미국·EMA·PMDA 1차 PAPILLON 기반 승인 대 한국 미설정의 형평성 논란.

통과 조건: 본 차수에서 **재심의 결정** (미통과·미부결 중간 status). 진입한 적응증은 EGFR 엑손20 삽입 변이 국소진행성·전이성 NSCLC 단독요법 — 2025년 7차 암질심 통과한 핵심 적응증. 다음 차수(6/4) 재상정 가능성은 매체 보도에서 명시되지 않았으나, 5차에서 부결이 아닌 재심의인 점은 추가 자료 보완 후 단기 재진입 가능성을 시사한다.

통과 히스토리 (한국 reimbursement에서 가장 오래 trajectory): - 2021 국내 식약처 허가 (엑손20 단독) - 2022~2025 암질심 도전 4회 이상 미설정 (단독 + 렉라자 병용 + carboplatin·pemetrexed 병용 묶음) - 2025년 7차 암질심: 엑손20 단독요법만 급여기준 설정 성공 (병용 모두 실패) - 2025-09 병용요법 일부 자진취하·재신청 보도 - 2026-01 1차 암질심: 3개 적응증 전부 재미설정 - 2026-05-07 5차 약평위: 엑손20 단독 첫 약평위 진입 → 재심의

총 한국 등재 journey 약 5년, 암질심·약평위 합산 도전 6회 이상.

시장 함의: 단독요법조차 약평위에서 재심의 받은 사실은 1.5억/년 약가가 평가금액과 mismatch 상태임을 시사. 한국 면역항암제·표적치료제 약가 ceiling이 실질적으로 작동함을 보여주는 사례. 단 더바이오(2026-06 보도)는 단독요법 4번째 시도의 청신호를 명시 — 6/4 차수 재상정 가능성 medium~high.

2. 4/2 4차 약평위 통과 약제 — Deep Dive

심평원 공식 보도자료(brdBltno=11763) 기준 결정신청 5종 + RSA 확대 1종. 의미 있는 4종을 본다.

2-1. 메탈라제주 (테넥테플라제) — 한국베링거 · 급성 허혈성 뇌졸중

통과 쟁점: 임상 11건·7,545명 메타분석에서 alteplase(액티라제) 대비 3개월 mRS 0-1 회복률 유의하게 높고 안전성 동등. 반감기 22분(액티라제 3.5분), 피브린 선택성 15배, 단회 정맥 볼러스 투여로 1시간 점적 불필요 — Door-to-Needle time 단축으로 골든타임 활용도 제고가 핵심 가치였다. ESO·캐나다·호주·뉴질랜드 가이드라인 권고.

통과 조건: 무조건부 통과. NHIS 약가협상 이미 착수, **이르면 2026년 7월 등재 가능성** 거론.

통과 히스토리: 액티라제 출시 후 약 20여 년 만의 새로운 뇌졸중 혈전용해제 옵션.

시장 함의: "20여 년 만의 신약 + 단회 투여 편의성" 스토리가 임상적 가치 입증과 결합 시 한국에서 무조건부·신속 등재 가능함을 보여주는 reference case.

2-2. 타브너스캡슐 (아바코판) — 메디팁 · GPA·MPA 혈관염

통과 쟁점: ANCA 관련 혈관염 보조요법 신약으로 글루코코르티코이드 감량 효과가 임상적 가치였다. 단 **미국 FDA가 2024년 시판 후 안전성 모니터링에서 중증 약물성 간손상(DILI) 76건·사망 8건·소실성 담관증후군(VBDS) 7건 경고 서한 발표**(일본 66건 최다). 발현 중앙값 46일.

통과 조건: 무조건부 통과. NHIS 약가협상 진입, 7월 등재 거론. 단 **건강사회를위한약사회 안전성 문제 제기**로 절차 진행 중. 식약처는 국내 환자지원프로그램 76명 사용 중 사망·VBDS 보고 없음 보고하며 4월 30일 의료기관에 간기능 모니터링 강화 서한 발송.

통과 히스토리: 미국 2021년 FDA 승인(Amgen Tavneos). 국내는 메디팁이 라이선스인하여 환자지원프로그램(EAP)으로 25개 기관 무상공급 중이었으며 정식 시판 전 단계에서 급여 등재 추진.

시장 함의: HIRA 약평위 통과 후에도 안전성 이슈가 NHIS 협상·건정심·고시 단계에 영향을 미치는 패턴 — 7월 등재 timeline 지연 trigger 가능. **약평위 통과가 등재의 종착점이 아닌 안전성 검증 환경에서의 출발점임을 보여주는 사례.**

2-3. 파드셉주 (엔포투맙베도틴) + 키트루다 병용 — 한국아스텔라스 · 요로상피암 1차 ★★ MSD 직접 영향 최대

통과 쟁점: EV-302 임상에서 cisplatin 적격성 무관 1차 전이성 요로상피암에서 화학요법 대비 사망위험 53% 감소. cisplatin ineligible 제한 없는 전체 1차 라인 적응증이라는 점이 핵심 (글로벌과 동일). 신약+신약 병용 = 고가 + 약가 사후 관리 복잡성이 재정 쟁점이었다.

통과 조건: 무조건부 적정 통과. 단 **세부 급여범위는 협상에서 추후 확정**. NHIS는 두 회사(한국아스텔라스·한국MSD)에 일괄 협상 명령을 내릴 가능성이 높음 — 통합 협상 구조. MSD는 키트루다 40개 이상 병용 적응증 + 사후관리 대상으로 타사 약제(파드셉) 협상으로 인한 키트루다 약가 인하 압박에 노출된다.

통과 히스토리: Astellas-Seagen(현 Pfizer) 공동개발 ADC. 글로벌 1차 적응증 FDA 2023년 12월 승인. 국내 식약처 1차 허가 후 본 차수 약평위 진입.

시장 합의 (MSD 직접 영향): - 한국MSD가 처음으로 요로상피암 1차 협상에 직접 참여하는 케이스 - 비용분담(cost-sharing) 협상에서 **키트루다 가격 보호 대 병용 등재 사이 trade-off 발생** - 키트루다 다적응증 약가 사후관리 전략의 시험대 - 통합 협상 결과가 한국MSD 키트루다 적응증 확대·사후관리 전략 baseline을 결정

2-4. 블린사이토주 (블리나투모맵) — 암젠코리아 · B-ALL RSA 확대

통과 쟁점·조건: 기존 RSA framework 위에 적응증 확대 layer 추가. 기존 급여(Ph+ 재발·불응 ALL 공고요법, 본인부담 30% 선별급여) → 새 적응증은 **Ph- 성인·소아 새 진단 B-ALL 1차 공고요법 (최대 4주기)**. 인구·치료 line 모두 큰 확대. 식약처 적응증 확대는 2025-02-14 선행. E1910/Children's Oncology Group 임상 근거.

통과 히스토리: 2014년 FDA 가속승인 → 다단계 확대. 한국 RSA 등재 후 적응증 확대마다 약평위 재심의 거치는 패턴. 본 차수가 가장 큰 인구 확대.

시장 합의: 기존 RSA framework 재활용 = 신속 등재 model. **MSD 자산(키트루다)의 RSA 범위 확대 협상에 적용 가능한 reference.**

2-5. 베오바·엘루시렘 — "평가금액 이하 수용" 조건부 패턴

베오바(과민성 방광·비베그론·제일약품)·엘루시렘 외 8품목(MRI 조영제·가도피클레놀·게르베코리아)은 모두 "업체가 평가금액 이하의 가격으로 수용하면 급여적정성 있음" 조건부 통과. 사실상 회사의 가격 수용 의사결정에 등재 timeline이 달린 구조 — **한국 약평위가 ICER·재정 부담 시 가격 양보를 전제로 통과시키는 표준 메커니즘.**

3. 보노프라잔 P-CAB 3종 동시 통과 의미 (5차 약평위)

5/7 5차에서 결정신청 통과 4종 중 3종이 보노프라잔 계열이었다. 보신티정(다케다 오리지널), 보노칸정(경보제약), 보노엠정(마더스제약) — 3종 동시 통과는 한국 reimbursement에서 흔치 않은 케이스다.

배경: 다케다 오리지널 보신티는 2019년 3월 허가 후 **약 7년간 미출시 보류** 상태였다. 이 사이 케이캡(HK이노엔)이 P-CAB 시장 1위를 굳혔고, 펙수클루·자큐보가 가세하며 PPI 시장을 잠식했다(2024 2분기 P-CAB 시장 점유율 20.2% / PPI 53.4%, 케이캡 처방액 단일제 첫 1조원 돌파).

통과 의미: 다케다가 7년 보류한 동안 경보·마더스는 푸마르산염 → 토실산염 염변경 자료제출의약품 트랙으로 동시 진입권 확보. **오리지널과 염변경 2종이 동시 약평위를 통과한 이례적 패턴** — 통상 오리지널 단독 등재 후 1~2년 뒤 제네릭 진입의 시퀀스를 압축한 셈. 2026년 4월 기준 보노프라잔 제네릭 36품목·19개사 허가 상황이라 시장 선점 경쟁이 본격화된다.

시장 합의: PPI(넥시움·란소프라졸) 절대 우위 시장에 보노프라잔 클래스 처방 옵션이 한 번에 3개 증가 — PPI → P-CAB 시장 교체 가속.

4. 6/4 6차 약평위 안건 후보

6/4 차수에 대한 심평원 공식 안건은 사전 공개되지 않으며 매체 D-2 시그널과 transition timing으로 추정한다.

4-1. 테빔브라(티슬렐리주맵) — 비원메디슨코리아 PD-1 ★ NEW · MSD 직접 영향

진입 가능성 ↑. 본 시스템의 일별 모니터링이 6/4 상정 예상 신호를 medcaltimes·dailypharm 복수 출처로 감지(본문 verify 미완, 사전 신호로 분류). 비원메디슨 한국법인은 2025년 6월 식약처 적응증 추가 승인 시점에 **"한국 출시 면역항암제 중 가장 빠른 속도로 급여권 진입 추진"**을 공식 언명. 2025년 마지막 암질심에서 식도암·위암·NSCLC 5개 적응증 통과 → 약평위 진입 단계.

예상 쟁점·조건: NCCN 가이드라인이 키트루다와 동등 권고 등재. 식도암 1차에서 PD-L1 무관(All-comer) 라벨이 한국 reimbursement에서 unique selling point. 통과 시 RSA + 사용량-약가 연동 + **약가 유연계약 옵션 다중 부착 가능성** ↑ (6/1 시행 직후 첫 약평위 적용).

MSD 시사점: 키트루다 대비 저가 포지셔닝 카드를 매체가 강조. 통과 시 면역항암제 시장의 가격 압박 베이스라인 변화.

4-2. 리브리반트 (아미반타맵) — 한국얀센 EGFR+ NSCLC

5/7 5차 재심의 후 6/4 재상정 후보. 더바이오 보도가 단독요법 4번째 시도 청신호 우세 분석 — Tier 1(가능성 매우 높음). 단 병용요법은 별도 트랙 보류 가능성.

4-3. 카보메틱스 (카보잔티닙) — 입센·HK이노엔 신장세포암

매체 보도상 신세포암 투명세포암 1차 급여확대가 "평가금액 이하 수용 조건"으로 통과·좌초 반복. 6/4 재진입은 가격 합의 시 가능. 조건부 패턴이 bottleneck.

4-4. 사이람자 (라무시루맵) — 한국릴리 위암

6/4 진입 직접 시사 매체 보도 검색되지 않음. **진입 가능성 낮음**.

5. 약평위 관련 정책 환경 변화

5-1. 약가 유연계약제 6월 1일 첫 시행 ★ 본 회의가 시행 후 첫 약평위

정부 약가 유연계약제(이종약가제)가 2026-06-01부터 첫 적용 개시됐다. RSA 적용 약제는 별도 상한금액 협상 대상에서 제외되며, **엑스탄디(엔잘루타미드·아스텔라스)**가 RSA → **약가 유연계약 전환 첫 케이스**다. 정부는 RSA 추가 확대보다 이종약가제 우회 정책 방향. 본 6/4 약평위는 시행 후 첫 약평위로, 신약 등재 결정 시 유연계약 옵션 부착 가능성의 첫 등장 시점이 된다.

5-2. 면역항암제 선별집중심사 — 운영 중간 점검 시점

심평원이 2026년부터 면역체크포인트억제제를 선별집중심사 신규 항목으로 지정(키트루다·옵디보·임핀지·젬퍼리 공통 적용). 키트루다 12개 요법 급여 확대 후 운영 시작. **6/4 회의가 시행 약 5개월차 시점** — 첫 운영 결과 비공식 검토 가능성. 운영 톤은 급여 제한이 아닌 사용 패턴·재정 영향 사전 모니터링 형식. 향후 키트루다 후속 적응증 신청 시 사용량 데이터 활용 영향.

5-3. RSA 확대 추세 — 항암 외 영역으로

블린사이토 RSA 확대(4차) 외에도 파센라(중증 호산구성 천식, 한국AZ) 약평위 통과 시 RSA 적용 등 **항암제 외 만성·중증 질환 영역으로 RSA 확장**. 한국 reimbursement의 RSA 활용 폭이 구조적으로 넓어지는 trend.

5-4. 10기 약평위 + 강준혁 신임 보험약제과장 — 운영 강도 변화 신호

- 10기 약평위 위원장 정현철 (심평원 상근위원, 연세암센터 출신 종양내과·한국임상암학회 이사장) — 항암제 임상 권위자의 약평위 통솔로 항암제 안전 심사 깊이 ↑ 예상
- 위원 74명 중 신규 44명(59.5%) — 운영 패턴 변화 가능성
- 강준혁 신임 보험약제과장(2026-05-18 부임) — 본 회의가 첫 정기 의결로 정책 톤 baseline 등록 시점

5-5. 메디칼타임즈 "면역항암제 현미경 심사" 시그널

5월 메디칼타임즈 분석에서 HIRA가 면역항암제 급여 확대에 대해 "현미경 심사" 강화 시그널을 보도. 통과 시 조건부("평균금액 이하 수용") 또는 사용량-약가 연동 부착 가능성 ↑.

6. MSD 자산 직접 영향 사안 (시니어 모니터링 우선순위)

본 차수와 직전 4·5차 통과 약제 환경이 한국MSD 키트루다·웰리렉에 미치는 직접 영향은 다음 4건이 핵심이다.

6-1. 파드셉+키트루다 요로상피암 1차 통합 협상 (4차 통과 후속) — 최우선 모니터링. 한국MSD가 요로상피암 1차 협상에 직접 참여하는 첫 케이스. 한국아스텔라스와 통합 협상 구조에서 키트루다 약가 인하 압력 대 cost-sharing 협상 결과가 키트루다 다적응증 약가 사후관리 전략의 시험대다. NHIS 협상 결과 timeline 7~9월 예상.

6-2. 티센트릭 NSCLC adjuvant 확대 logic (5차 통과) — 키트루다 KEYNOTE-091 후속 등재 직접 reference. PD-L1 50%+ subpopulation 한정 + 기존 RSA 위에 추가 layer + BIA 통제 — 모든 logic이 키트루다 KEYNOTE-091 adjuvant 한국 등재 시 직접 적용된다. 사전 임상 패키지·BIA 시뮬레이션·RSA layer 설계 점검 필요.

6-3. 테빔브라 6/4 통과 가능성 (6차 안전 후보) — 키트루다 가격 압박 베이스라인 변화. NCCN 동등 권고 + 키트루다 대비 저가 포지셔닝이 통과 시 한국 면역항암제 시장의 가격 압박 베이스라인 변화 시그널. 약가 유연계약제·사용량-약가 연동 다중 부착 가능성. 6/5 결과 발표 시 키트루다 후속 적응증 신청 협상 환경 첫 영향 파악.

6-4. 면역항암제 선별집중심사 운영 중간 검토 (정책 환경) — 키트루다 사용량 데이터 활용 영향. 시행 5개월차 시점으로 첫 운영 결과 비공식 검토 가능성. 키트루다·옵디보·임핀지 공통 적용이므로 후속 적응증 확대 협상 시 사용량 데이터 활용 영향. 9월 이후 첫 공식 검토 결과 시점에 재평가.

6/4 D+1 (6/5) 자동 모니터링 예정

본 시스템은 6/5 시점에 심평원 공식 보도자료 자동 fetch + 본 차수 예측 vs 실제 결과 비교를 수행한다. 결과는 자동 GitHub commit 후 결과 리뷰 보고서로 발송된다.

자동 발견 사항(자카비·포말리스트의 약평위 우회 직접 등재 등)도 차수 누적 데이터로 활용돼 다음 차수 안전 후보 예측 정확도가 향상된다.